

Gota · crise aguda e prevenção

Crise de gota = artrite inflamatória aguda, classicamente 1ª MTP. Trate a inflamação na crise; deixe o hipouricemiante para a estratégia de longo prazo, com profilaxia ao iniciar.

Diagnóstico

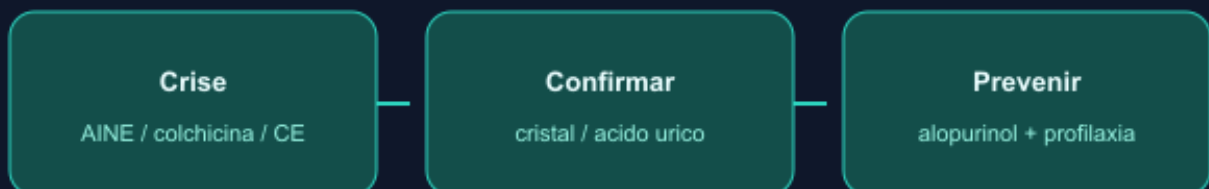
Dica - Diagnóstico

Padrão-ouro: cristais de urato (-) birefringentes no líquido sinovial. Ácido úrico pode estar normal na crise — não exclui gota.

Não misture fases: primeiro apague o fogo articular; depois baixe o urato com plano.

Manejo da gota

Crise -> resolução -> prevenção



Conduta

- Crise: AINE, colchicina precoce ou corticoide (via oral/intra-articular) conforme comorbidades
- Evitar iniciar/ajustar alopurinol no auge da crise sem cobertura anti-inflamatória
- Alvo de uricemia tipicamente <6 mg/dL (<5 se tofos/doença grave)
- Ajustar alopurinol na IRC; atenção a interação com azatioprina

Gota × pseudogota

Item | Gota (urato) | Pseudogota (CPP)

Articulação típica | 1ª MTP / pé | Joelho / punho

Cristal | Agulha, birefringência (") | Romboide, birefringência (+)

Radiografia | Tofos / erosões | Condrocalcinose

Contexto | Hiperuricemia, diurético | Idoso, metabólico

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Monoartrite aguda é artrite séptica até prova em contrário se houver febre/risco — puncione. Não 'trate gota no escuro' sem considerar infecção.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1